

Schultererschmerz: welche Bildgebung wann?

Ein Leitfaden für die Praxis. In vier Schritten.

Weiterwischen >

SCHRITT 1

Erst das Röntgen

- Beim chronischen, atraumatischen Schulterschmerz die geeignete Erstuntersuchung
- Erfasst Omarthrose, Tendinosis calcarea und knöcherne Veränderungen
- Grundlage für die Frage, ob überhaupt weiter abgeklärt werden muss

SCHRITT 2

Sonographie bei Rupturverdacht

- Bei Verdacht auf eine komplette Rotatorenmanschettenruptur kein Behelf
- Strahlenfrei, dynamisch, kurzfristig verfügbar
- Die Trefferquote hängt weniger am Untersucher als oft angenommen

92 %

Sensitivität der Sonographie bei kompletter Rotatorenmanschettenruptur. Die MRT liegt bei 94 %. Für diese Fragestellung gleichwertig.

SCHRITT 3

Wann die MRT trägt

- Bei unklarem Vorbefund und vor einer operativen Versorgung
- Zeigt Rissform, Retraktion, fettige Degeneration, Knochenmarködem
- Wichtig: bei Partialrupturen sinkt die Sensitivität beider Verfahren auf rund zwei Drittel

88 %

Sensitivität der MR-Arthrographie bei Labrumläsionen, gegenüber 76 % nativ. Der Zugewinn gilt für Labrum und Instabilität.

Unklare Fragestellung?

Rufen Sie uns vor der Überweisung an. Wir klären die Fragestellung gemeinsam und ersparen Ihren Patientinnen und Patienten den Zwischentermin.

www.rnz-radiologie.de

Quellen: Cochrane 2013 · ACR 2022 · Smith 2012